

Informe de análisis Gestión del Servicio Médico

TANDANOR · Primer semestre de 2026
Con mejora de aptitudes para tareas críticas implementada en el segundo semestre

Preparado para Dirección · Emisión: 7 de octubre de 2026 · Versión para revisión

La gestión documentada abarca atención, administración, seguimiento de casos, prevención y preparación de emergencias. El análisis encuentra mayor demanda registrada en el segundo trimestre y oportunidades concretas para mejorar disponibilidad y trazabilidad. El ausentismo se evalúa como una dimensión organizacional del conjunto.

Dimensión	Resultado que puede presentarse	Lectura para Dirección
Actividad	2.542 registros propios; 1.295 clínicos; 80 de contratistas aparte.	Volumen de trabajo observado; clínica y administración están diferenciadas.
Seguimiento	BP: 24 altas y 14 activos. ART: 26 altas y 6 activos al 30/06.	Flujo de episodios administrativos; requiere historia de controles para evaluar cumplimiento.
Prevención	46 aplicaciones antigripales fechadas; una actividad de capacitación fechada.	La cobertura final y la asistencia deben conciliarse.
Respuesta y stock	3/4 DEA operativos declarados; 2 líneas de stock bajo mínimo.	Priorizar verificación y cierre de brechas por criticidad.
Desarrollo 2S	Programa de aptitudes críticas incorporado: base de 104 personas.	Avance organizativo posterior al 1S; ejecución y vigencia se miden con evidencia efectiva.

Tres decisiones propuestas

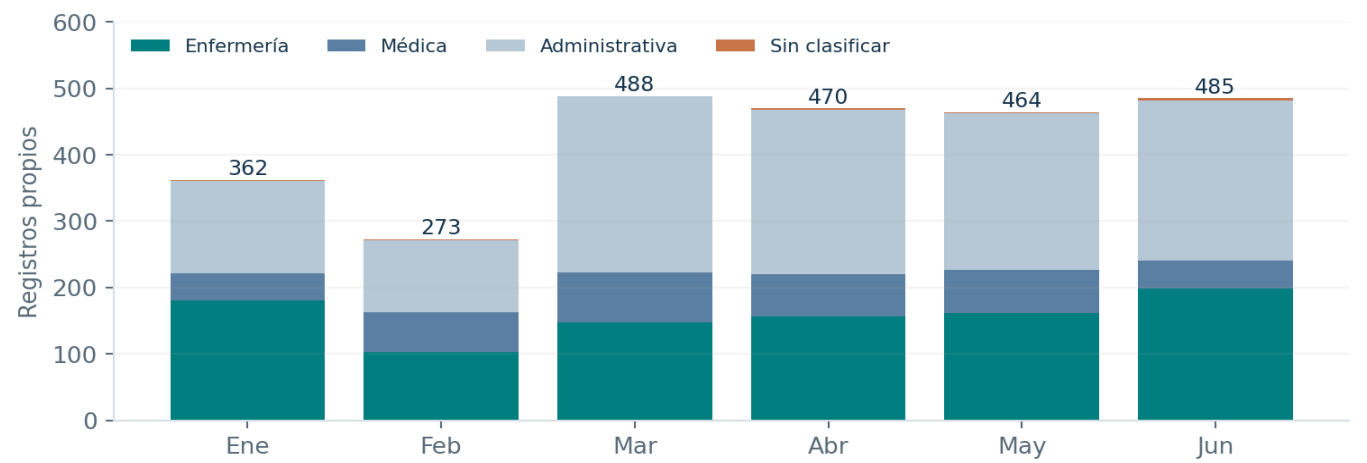
1. Verificar y resolver las observaciones de equipos y abastecimiento. 2. Acordar registros de seguimiento, recorridos y capacitación que permitan demostrar realización y cierre. 3. Conciliar campaña antigripal y consolidar el programa de aptitudes críticas con fechas efectivas y vigencia.

Se revisaron 20 documentos originales. El Excel integral contiene 56 indicadores: 45 con valor calculado y 11 pendientes. Parte de los valores describe estados registrados sin corte certificado; la sección metodológica precisa qué puede concluirse.

1. Demanda y organización del trabajo

Período: enero-junio 2026 · Registros de AT. DIARIAS y CONTRATISTAS

Los 2.542 registros propios se distribuyen en 947 de enfermería, 348 médicos, 1.238 administrativos y 9 sin clasificación. Las actuaciones clínicas suman 1.295. La base de contratistas agrega 80 registros de otra población; se informa separada para mantener comparabilidad.



Tipo de registro	T1: enero-marzo	T2: abril-junio	Variación
Total propio	1.123	1.419	26,4%
Clínico propio	608	687	13,0%
Administrativo	512	726	41,8%

El volumen propio aumenta 26,4% en T2. La clínica aumenta 13,0%, mientras la administración explica 72,3% del incremento de registros. Esto orienta a revisar circuitos documentales y distribución de tareas; la base no incluye tiempo por actuación para calcular productividad o dotación necesaria.

Licencias: ordenar el registro para demostrar gestión

Hay 1.694 actuaciones con campos de licencia, de las que 614 tienen inicio y fin válidos: 36,2%. Entre ellas se identifican 566 intervalos distintos y 48 repeticiones. Conviene homogeneizar identificación de episodio, fechas y unidad de duración, manteniendo las horas RRHH como medida de ausencia laboral.

Se detectaron 7 filas exactamente repetidas: el escenario depurado sería 2.535 registros propios. Las 351 identidades estimadas reflejan identificación disponible; falta un padrón elegible al corte para afirmar cobertura poblacional.

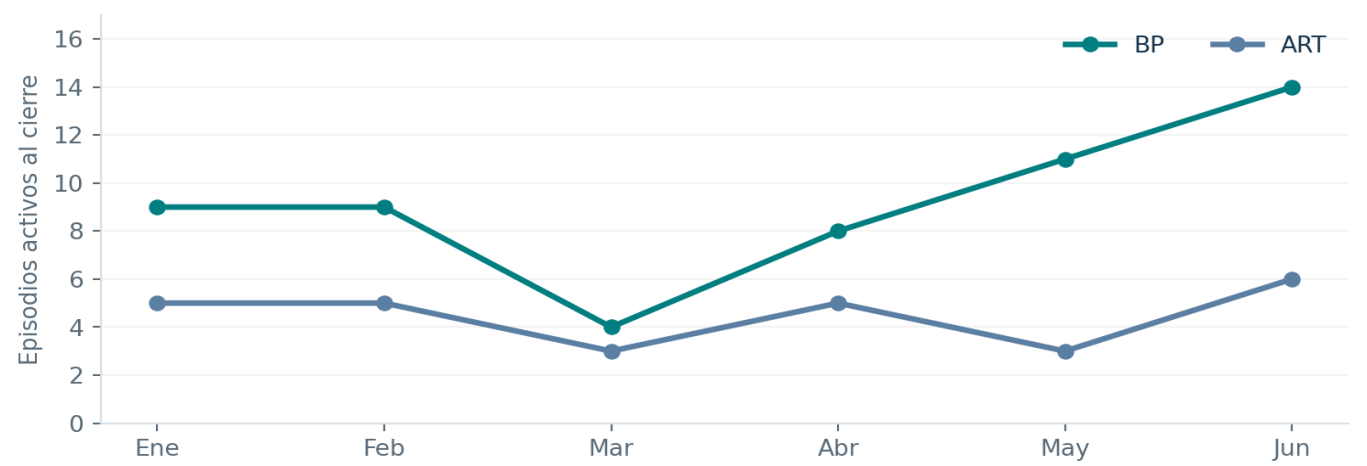
Fuente: Planilla Tandanor (1).xlsx · AT. DIARIAS, CONTRATISTAS. Fechas válidas; agrupación por tipo ATENCION.

2. Seguimiento de BP y ART

Período: enero-junio 2026 · Balance de episodios administrativos

El seguimiento puede mostrarse mediante entradas, altas y casos que permanecen activos. En BP se observan 32 personas y 38 episodios administrativos; en ART, 30 personas y 32 casos con presencia en el semestre. Se diferencian personas, filas y episodios para conservar unidades de conteo consistentes.

Flujo semestral	BP	ART
Arrastre al inicio	8	4
Inicios en 1S	30	28
Altas registradas en 1S	24	26
Activos inferidos al 30/06	14	6



BP: el stock pasa de 4 episodios activos al final de marzo a 14 al cierre de junio. T2 incorpora 20 inicios y registra 10 altas. La acumulación justifica revisar la agenda y las necesidades de seguimiento; la información no atribuye esa evolución a la calidad de atención.

ART: los 28 inicios de 1S están clasificados como 19 AT, 8 AI y 1 EP según la fuente. Trece contienen mención de rechazo en las observaciones actuales: se requiere resolución documentada y fecha para interpretar aceptación o rechazo.

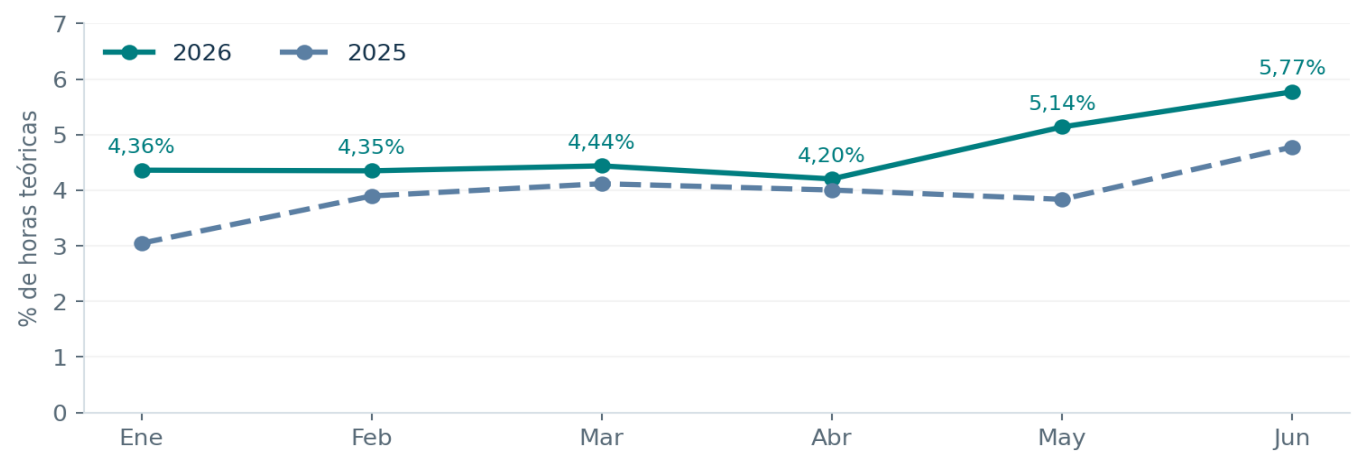
La mediana de duración completa en episodios con alta en 1S es 41 días calendario en BP y 10 en ART. Describe cohortes diferentes y seleccionadas por cierre; los casos abiertos tienen observación incompleta.

Fuente: Planilla Tandanor (1).xlsx · BP y ART. BP: unión de intervalos contiguos/superpuestos por persona. ART: deduplicación por persona, inicio, contingencia y texto diagnóstico.

3. Ausentismo y focos organizacionales

Período comparable: primeros semestres de 2025 y 2026 · Denominador: horas normales teóricas

En 1S2026 se registran 18.895 horas médicas sobre 400.632 horas teóricas: 4,72%. En 1S2025 fueron 15.729 horas y 3,92%. El aumento de tasa es 0,795 puntos porcentuales, calculado antes de redondear las tasas visibles.



Horas médicas	1S2025	1S2026	Diferencia
Enfermedad	13.349	14.880	+1.531
Accidentes / ART	2.380	4.015	+1.635
Total médico	15.729	18.895	+3.166

ART explica matemáticamente 51,6% del aumento interanual de horas. Dentro de 2026 la dinámica cambia: la enfermedad aumenta 2.512 horas de T1 a T2 y ART disminuye 1.121; el incremento neto es 1.391 horas. Las tasas trimestrales pasan de 4,38% a 5,05%. Conviene analizar ambos comparativos para orientar el seguimiento.

Intervención focalizada

Mecánica, Casco y Acero y Cobrería concentran 53,6% de las horas médicas. La propuesta es revisar casos, puestos, retorno y medidas preventivas junto con RRHH y Seguridad e Higiene, complementando volumen con tasa sectorial y exposición.

Los días administrativos BP/ART no se suman a las horas RRHH: describen unidades distintas y podrían duplicar ausencias. El total médico es enfermedad + accidentes/ART, y las tasas del semestre son cocientes de sumas. Las ausencias son un resultado multicausal de la organización y no evalúan por sí solas la eficacia del Servicio Médico.

Fuente: Indicador Ausentismo junio.xlsx; seis archivos Índice de enero a junio 2026. Comparación histórica recalculada desde horas.

4. Vacunación, capacitación y equipo

Actividad fechada de 1S y estados del último registro, presentados con su alcance

Campaña antigripal

Fuente	Resultado	Alcance
Registro parcial fechado	46 aplicaciones: 32 marzo y 14 abril.	Actividad documentada dentro de 1S.
Padrón de campaña	193 SI / 432 = 44,7%.	Marcación sin fechas individuales ni cierre histórico confirmado.
Tablero previo	200 vacunaciones.	Cifra pendiente de conciliación.

El cruce de las 46 aplicaciones encuentra 41 con SI en padrón, 2 con NO, 1 identificador fuera del padrón y 2 sin identificador. Estas fuentes se superponen: sumarlas duplicaría registros. La gestión debe cerrar un padrón de personas únicas con fecha de aplicación y población elegible al corte.

Decisión propuesta: respaldar el cierre documentado de campaña. Con aplicaciones depuradas y padrón elegible se podrá informar cobertura semestral y, si corresponde, por sector.

Capacitación y capacidad del servicio

La fuente contiene una actividad fechada el 20/05/2026, denominada RPC —a confirmar como RCP—, 20 convocados y estado Aprobado. La asistencia está vacía. Se presenta como actividad registrada; la ejecución y el resultado requieren evidencia. Las otras seis filas de cursos sin fechas no permiten completar un indicador de realización.

El último registro de equipo incluye 6 integrantes: 2 de medicina, 3 de enfermería y 1 de psicología. Cinco consignan formación RCP vigente sin fechas de certificados. Para evaluar cobertura horaria y formación por rol, faltan dedicación efectiva, fechas y población objetivo.

Próximo paso de gestión

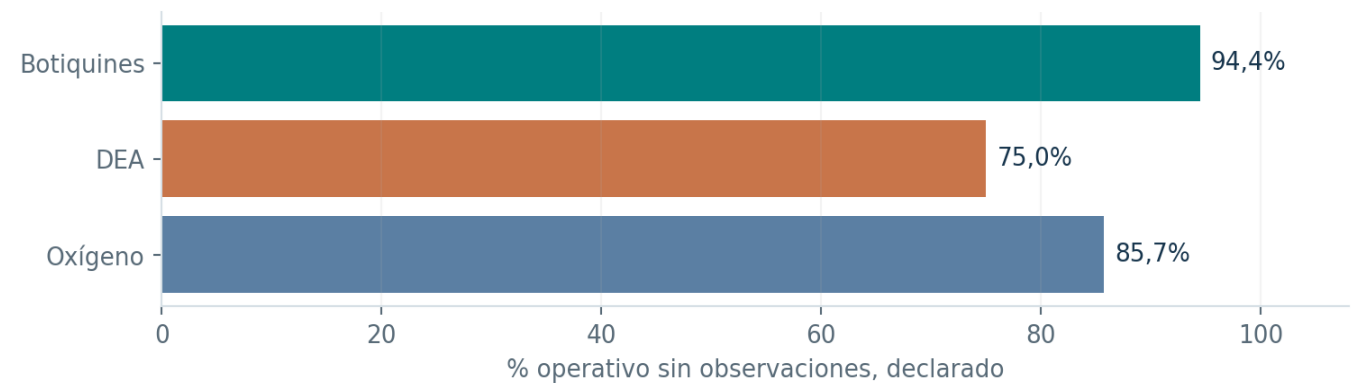
Acordar el plan por tema y población objetivo, registrar fecha prevista y efectiva, asistentes deduplicables y evaluación. Convocados, asistentes, personas capacitadas y certificados vigentes son medidas diferentes; el tablero debe conservarlas separadas.

Fuente: Control Completo Servicio Médico · Antigripal 2026, vacunacion, Capacitaciones y Personal; PDF Listado de vacunación 2026 como respaldo por conciliar.

5. Preparación de emergencias

Último estado declarado; fechas heterogéneas. La revisión funcional fechada habilita un corte operativo.

El detalle comprende 47 activos: 36 botiquines, 4 DEA y 7 cilindros de oxígeno. Tres figuran no operativos —uno de cada categoría— y un botiquín adicional tiene observaciones. Estos resultados permiten ordenar verificación y resolución por ubicación y criticidad.



Activo / ubicación consignada	Observación	Acción de verificación propuesta
BOT-05 · Dirección de Operaciones	No localizado.	Confirmar ubicación y reposición o cobertura alternativa.
BOT-10 · Legales	Reponer alcohol.	Actualizar contenido y evidencia de cierre.
EQ-003 · Storni	DEA fuera de servicio, retirado para reposición.	Documentar reparación/reposición o contingencia.
OX-02 · Shock room	Oxígeno no operativo.	Confirmar condición y disponibilidad funcional.

35 de 36 botiquines muestran última revisión fechada en 1S; uno registra agosto. Esa marca evidencia una última fecha, pero no reconstruye controles anteriores ni mide cumplimiento del programa. Tres cilindros carecen de vencimiento registrado; se propone completar la información de lote y control.

Además se registran 2 ambulancias y 1 carro de paro. Una ambulancia no tiene estado consignado y el carro carece de un checklist integral acreditado. Se necesita una revisión por unidad y criterios validados para evaluar completitud y disponibilidad.

Fuente: Control Completo · BOTIQUINES, Dea, Oxígeno y Ambulancias c-Paro stock. Porcentajes del gráfico: 34/36, 3/4 y 6/7.

6. Medicamentos: stock y consumo

Separar alerta de abastecimiento, cantidad consignada y movimiento completo de farmacia

Inventario sin corte certificado	Valor	Interpretación
Líneas con stock y mínimo numéricos	44	Presentaciones distintas; el indicador se calcula por línea.
Líneas que alcanzan el mínimo	42 / 44 = 95,5%	Hay 2 líneas bajo mínimo; validar y resolver.
Líneas exactamente en el mínimo	6	Revisar regla de reposición según demanda.

Las dos líneas bajo mínimo están marcadas como OK en la fuente. La alerta debe salir de la comparación de cantidades contra mínimos validados, y la gestión debe documentar reposición o revisión del umbral. El porcentaje de líneas suficientes no pondera criticidad ni describe la disponibilidad durante todo el semestre.

Dos registros de consumo con alcances diferentes

Registro	Comprimidos	Inyectables	Alcance
Hoja mensual: mayo	258	15	Año y universo por confirmar.
AT. DIARIAS: mayo	207	18	Cantidades positivas consignadas.
AT. DIARIAS: enero-junio	952	59	Acumulado parcial; enero sin cantidades.

Los campos vacíos de actividad diaria no equivalen a cantidades cero. La diferencia de mayo justifica conciliar período, alcance y criterio; no prueba pérdidas ni errores de dispensación. Las cantidades no se suman entre fuentes o presentaciones ni se extrapolan al semestre.

El cruce por código tampoco es confiable: sólo una de las 25 líneas mensuales coincide en nombre con el stock para igual código. Se requiere un catálogo único de producto, presentación y unidad, con entradas, salidas, lotes y saldo mensual.

Decisión propuesta: validar mínimos y catálogo, resolver las dos brechas de stock y acordar cierre mensual conciliado. Costos, rotación y días de cobertura requieren movimientos completos y precios comparables.

Fuente: Control Completo · Medicaciones en stock y Medicacion Usadas Mens; Planilla Tandanor · AT. DIARIAS, campos COMPRIMIDOS e INYECTABLES.

7. Mejora de aptitudes y presencia en planta

Aptitudes para tareas críticas: implementación de 2S confirmada por la responsable del servicio

Un avance organizativo posterior al primer semestre

El programa de exámenes de aptitud para tareas críticas se incorporó en el segundo semestre. Corresponde destacarlo como ampliación de la gestión, con indicadores de ejecución y vigencia propios del nuevo período.

Base ESTOC de seguimiento 2S	Valor	Alcance
Personas en la base	104	Población del archivo; confirmar padrón elegible por tarea.
Estado APTO cargado	25	Estado registrado; acreditar fecha real y vigencia.
Estado PENDIENTE	79	Pendiente según última planilla.
Proporción de estados APTO	24,0%	25/104; no equivale a cobertura de exámenes realizados.

Las fechas del archivo corresponden a julio-noviembre y 103 de 104 coinciden con el cronograma. Para medir la implementación se necesitan fecha efectiva del estudio, tarea crítica, conclusión acreditada y vencimiento. Esto permite distinguir agenda, ejecución y aptitud vigente.

Recorridos de planta y cierre de hallazgos

La dimensión fue identificada como prioridad por la responsable. La documentación cargada no permite cuantificar recorridos, cumplimiento de agenda o cierres. El tablero los deja pendientes; las revisiones de botiquines no representan por sí solas visitas integrales a planta.

Registro propuesto: fecha prevista y real del recorrido, sector, alcance, hallazgo, prioridad, responsable, vencimiento, cierre y verificación. Indicadores iniciales: recorridos realizados/programados y hallazgos cerrados en plazo/hallazgos con vencimiento en el período.

Las restricciones disponibles corresponden a dos registros con inicio en julio. Su lectura se incorpora al seguimiento posterior, sin inferir la existencia o ausencia de restricciones durante 1S.

Fuente: Seguimiento_Aptitudes_Medicas_ESTOC_AJUSTADO_VACACIONES.xlsx; Planilla Tandanor · RESTRICCIONES; confirmación de la responsable sobre implementación en 2S.

8. Decisiones y plan de consolidación

Propuestas para revisión de Dirección; responsables y prioridades sujetos a acuerdo

Prioridad propuesta	Acción	Responsable propuesto	Evidencia de cierre
Alta	Verificar los 3 activos no operativos y el botiquín con observaciones; resolver o documentar contingencia.	Servicio Médico, Mantenimiento, HyS.	Prueba funcional fechada y estado por ubicación.
Alta	Completar estado y checklist de ambulancias/carro; fechas faltantes de oxígeno.	Enfermería, Mantenimiento.	Checklist validado y constancia de resolución.
Alta	Resolver las 2 líneas bajo mínimo con reglas y presentaciones validadas.	Enfermería, Compras.	Reposición o mínimo revisado con evidencia.
Consolidación	Conciliar aplicaciones, padrón y PDF de campaña antigripal.	Enfermería, RRHH.	Padrón elegible y aplicaciones únicas fechadas.
Consolidación	Registrar historia de controles BP/ART y estado documental ART.	Servicio Médico, ART, RRHH.	Agenda, fecha real, episodio y resolución.
Consolidación	Acordar plan de capacitación y registro de recorridos/hallazgos.	Servicio Médico, HyS, RRHH.	Plan, asistencia y cierres verificados.
Desarrollo 2S	Consolidar evidencia de realización y vigencia de aptitudes críticas.	Medicina laboral, RRHH, responsables operativos.	Padrón por tarea, estudio efectivo, dictamen y vencimiento.

Cómo dar continuidad al tablero

Se propone un cierre mensual con un referente por fuente, corte compartido y evidencia de validación. Cada indicador debe tener definición, numerador, denominador, período y acción cuando corresponda. Dirección puede acordar metas prospectivas una vez completados los datos; el informe no utiliza semáforos heredados sin aprobación.

La hoja Metas y acciones del Excel permite registrar objetivo, responsable, plazo y evidencia. El catálogo distingue valores calculados de pendientes, y separa las medidas de actividad de los resultados y las condiciones de disponibilidad.

Fuente: Matriz elaborada a partir de los hallazgos auditados. Los responsables y prioridades son propuestas, no compromisos aprobados.

9. Método, calidad y límites de lectura

Alcance de la evidencia y criterios usados en el informe

Corte / evidencia	Dimensiones	Tratamiento
Enero-junio 2026	Actividad, horas RRHH, flujo administrativo BP/ART, accidentes y aplicaciones fechadas.	Resultados agrupados por fecha válida y población de fuente.
Último estado disponible	Stock, equipamiento, padrón antigripal y equipo profesional.	Fecha de corte heterogénea o sin certificar; no disponibilidad histórica.
Programa implementado en 2S	Aptitudes de tareas críticas y agenda ESTOC.	Mejora posterior al cierre; programación separada de ejecución.

Controles y definiciones principales

Se conciliaron las horas médicas de los seis índices sectoriales con RRHH: los totales coinciden mes a mes. Los informes acumulados no se suman entre sí. Las tasas semestrales se calculan como suma de numeradores dividida por suma de denominadores; para 2025 se recalcularon las tasas médicas desde las horas primarias.

En BP, los intervalos superpuestos o contiguos de una misma persona se unen para construir episodios administrativos; en ART se deduplica por persona, inicio, contingencia y texto diagnóstico. Esos criterios no sustituyen la validación clínica de continuidad ni la resolución formal de una contingencia.

La fecha de última consulta está presente en 39/39 filas BP y 32/32 ART. Catorce BP y dos ART muestran últimas consultas posteriores al cierre: el campo conserva una actualización y no una historia completa. Por eso no se afirma cumplimiento del seguimiento programado.

Indicador	Cálculo
Tasa médica	(Horas enfermedad + horas accidentes/ART) / horas teóricas.
Balance de activos	Stock inicial + inicios del período – altas del período.
Estado operativo declarado	Activos consignados operativos / activos del grupo.
Cobertura final de campaña	Personas únicas vacunadas con fecha / población elegible al corte; pendiente.

Se conservaron los 20 originales y sus huellas SHA-256. El entregable contiene información agregada; los datos nominales y diagnósticos individuales permanecen en las fuentes. La interpretación no atribuye causalidad ni demuestra cumplimiento normativo, adecuación clínica, retorno efectivo o productividad sin la evidencia correspondiente.

Anexo. Documentos y trazabilidad

Los 20 documentos originales revisados. Referencia de versión: prefijo de la huella SHA-256.

Nº	Documento	Uso	SHA-256 (prefijo)
1	Copia de Control_Completo_Servicio_Medico_Astillero2.xlsx	Prevención e inventarios.	a021569f6058
2	Dashboard_Gestion_Servicio_Medico_Tandanor_2026.xlsx	Antecedente; no fuente aditiva.	c999e4c57579
3	Indicador Ausentismo ENERO (1).xlsx	RRHH; historia y versiones.	d4d7a78a011c
4	Indicador Ausentismo abril.xlsx	RRHH; historia y versiones.	efc4fd0b3f21
5	Indicador Ausentismo febrero.xlsx	RRHH; historia y versiones.	7cddf9eada9e
6	Indicador Ausentismo junio.xlsx	RRHH; historia y versiones.	cd8189842754
7	Indicador Ausentismo marzo.xlsx	RRHH; historia y versiones.	8da7782658d6
8	Indicador Ausentismo mayo.xlsx	RRHH; historia y versiones.	fe5243655741
9	Indice Enero 2026.xlsx	Sectores, horas y vacaciones.	d06747e5ce31
10	Indice Febrero 2026.xlsx	Sectores, horas y vacaciones.	0a00c5fea3f9
11	Indice abril 2026.xlsx	Sectores, horas y vacaciones.	d0183ac436fd
12	Indice junio 2026.xlsx	Sectores, horas y vacaciones.	8458ce1b6e33
13	Indice marzo 2026.xlsx	Sectores, horas y vacaciones.	2cb3515cf0ba
14	Indice mayo 2026.xlsx	Sectores, horas y vacaciones.	f4d2f6b6583a
15	KPI´s Servicio Medico - Tandanor 1er Semestre 2026.xlsx	Antecedente; no fuente aditiva.	4b6a1d37e4cc
16	Listado de vacunación 2026.pdf	Respaldo de campaña por conciliar.	fa60eabd8061
17	Nomina Tandanor.. - copia.xls	Población; corte no certificado.	67ac2a8d02af
18	Planilla Tandanor (1).xlsx	Actividad, BP, ART y restricciones.	c4aa670a8455
19	Seguimiento_Aptitudes_Medicas_ESTOC_AJUSTADO_VACACION ES.xlsx	Programa de aptitudes 2S.	e7ed70656f17
20	Tablero_Medicina_Laboral_Tandanor_2026_v4.xlsx	Antecedente; no fuente aditiva.	19f7b19ad09c

Los antecedentes de tableros se revisaron para identificar definiciones y discrepancias. Los resultados se reconstruyeron desde las fuentes de detalle y los registros temporales; los resúmenes previos no se sumaron como actividad independiente.

Excel integral de referencia: [catálogo KPI](#), [cálculos mensuales](#), [fuentes y acciones](#).